

MODULE LÉSIONS MUSCULOSQUELETTIQUES

Ce qu'il faut retenir

Aide-mémoire du volet en ligne

Chaque leçon du module en ligne est ramenée à ses quatre ou cinq idées essentielles. Ce document ne remplace ni le manuel, ni les capsules interactives, ni la pratique en classe. Il vous sert de point de repère avant le volet en présentiel et de rappel rapide après la formation.

Les lésions musculosquelettiques, surtout aux membres inférieurs, sont parmi les blessures les plus fréquentes en régions isolées. Le volet en ligne vous donne le raisonnement : mécanisme, évaluation, décision. Le volet en classe vous donne les mains : l'immobilisation, une articulation et un os, avec votre propre matériel.

CONTENU DU MODULE — QUATRE LEÇONS

00 Introduction au chapitre

01 Le système musculosquelettique

02 L'évaluation et la prise en charge

03 Les attelles

REPÈRES EN BAS DE CHAQUE FICHE

Manuel de l'apprenant : section correspondante dans l'encyclopédie en ligne, accessible après authentification via siriusmedx.com/manuel.

Manuel terrain : pages 105 à 154 du guide de poche à emporter en région isolée.

00

Introduction au chapitre

Trois leçons pour comprendre, décider et immobiliser

Pourquoi ce chapitre : sur le terrain, vous ne verrez jamais l'os. Vous verrez une douleur, une déformation, une incapacité. Votre travail est de décider si vous pouvez laisser marcher, s'il faut immobiliser, et à quelle vitesse il faut évacuer.

- 1 Quatre atteintes à reconnaître.** Fracture (l'os), luxation (l'articulation), entorse (le ligament), claquage (le muscle ou le tendon). Leurs signes se ressemblent souvent ; dans le doute, traitez comme une fracture.
- 2 Une règle avant toutes les autres : la CSM.** Circulation, sensibilité, motricité en aval de la blessure, avant et après chaque manœuvre, puis à intervalles réguliers. Une CSM atteinte change la priorité d'évacuation.
- 3 GREC pour presque tout.** Glace, repos, élévation, compression. C'est la prise en charge commune aux quatre atteintes une fois la blessure stabilisée.
- 4 En ligne le raisonnement, en classe les mains.** Le manuel terrain (pages 128 à 154) est votre outil de référence pour les immobilisations : regardez l'image, reproduisez-la. En classe, chaque participant immobilise au moins un os et une articulation avec son propre matériel.
- 5 Trois scénarios dans le module en présentiel.** Entorse du genou ou de la cheville, claquage musculaire, crampes musculaires, en plus de la fracture. Préparez-vous en revoyant les signes et la prise en charge de chacun.

01

Le système musculosquelettique

Comprendre les structures pour reconnaître ce qui est blessé

L'appareil locomoteur, c'est le squelette et la musculature : os, articulations, ligaments, cartilages, muscles et tendons. Ensemble, ils donnent la forme au corps, protègent les organes, produisent le mouvement et la chaleur.

Structure	Lésion typique	Ce qui la trahit
Os	Fracture fermée ou ouverte	Douleur localisée, déformation, incapacité, crépitation
Articulation	Luxation	Déformation, articulation figée, perte de mobilité
Ligament	Entorse	Douleur au mouvement, enflure, instabilité
Muscle et tendon	Claquage, tendinite, crampe	Douleur à la contraction, raideur, brûlure en début d'effort

Figure 1 — Quatre structures, quatre lésions typiques, et ce qui les trahit à l'examen.

- 1 Les os : cinq types, deux squelettes.** Longs, courts, plats, irréguliers, sésamoïdes. Le squelette axial protège (crâne, colonne, cage thoracique) ; l'appendiculaire bouge (membres, ceintures). Il faut une force considérable pour fracturer un os : cherchez le mécanisme.
- 2 Les articulations mobiles : les plus mobiles sont les moins stables.** Cartilage, capsule, liquide synovial, ligaments. Épaule, rotule et doigts sont les luxations les plus fréquentes. Charnière (genou, coude) : un seul plan ; sphéroïde (hanche, épaule) : tous les plans.
- 3 Les ligaments limitent l'amplitude.** Un mouvement forcé au-delà de l'amplitude normale étire ou déchire le ligament : c'est l'entorse. Poussé plus loin, il déloge l'articulation : c'est la luxation.
- 4 Les muscles et les tendons tirent, ils ne poussent pas.** Le muscle est élastique et très vascularisé, il guérit bien. Le tendon est riche en nerfs (douleur intense) mais pauvre en vaisseaux (guérison lente). Claquage : étirement excessif. Tendinite : surcharge répétée.
- 5 Le vocabulaire du mouvement décrit la blessure.** Flexion, extension, abduction, adduction, rotation, inversion et éversion. « Chute sur la main en hyperextension » oriente déjà vers la structure atteinte.

MANUEL DE L'APPRENANT

Section 9.1, Anatomie et physiologie de l'appareil locomoteur · [Encyclopédie en ligne](#)

MANUEL TERRAIN

N/A

EN LIGNE

Scène ThingLink : anatomie superficielle ; vidéo du système musculosquelettique

02

L'évaluation et la prise en charge

Une démarche unique pour les fractures, luxations, entorses et claquages

Même démarche, quatre atteintes. Mécanisme, PQRST, examen comparatif, CSM, puis GREC, immobilisation et décision d'évacuation.

Situation	Prise en charge	Évacuation
Fracture fermée, CSM intacte	GREC, immobiliser, CSM aux 15 min	Semi-urgente
Fracture fermée, CSM atteinte	Traction douce dans l'axe si os long angulé, immobiliser, choc	Urgente
Fracture ouverte	Saignement, irrigation sans frotter l'os, pansement, attelle, accès à la plaie	Urgente
Luxation	Position trouvée, CSM ; réduction douce seulement doigt, orteil, rotule	Urgente si CSM atteinte, sinon rapide
Entorse, claquage	GREC, soutien, repos	Selon la capacité à marcher

Figure 2 — De la situation constatée à la vitesse d'évacuation.

- 1 Le mécanisme oriente tout.** Force directe (fracture au point d'impact), indirecte (à distance) ou de torsion (entorse, fracture spiroïde). Type, direction et ampleur de la force : vos premières données objectives.
- 2 PQRST puis examen comparatif.** Un membre à la fois, palpation sur toute la longueur de l'os, comparaison avec le côté sain, amplitude active puis passive. Bagues et montres retirées. Dans le doute, traitez comme une fracture.
- 3 CSM : le chiffre qui décide de l'évacuation.** Circulation (pouls distal, couleur, chaleur, remplissage capillaire), sensibilité, motricité. Une CSM atteinte rend l'évacuation urgente et justifie, pour un os long grossièrement angulé, une traction douce dans l'axe. Arrêtez si résistance ou douleur croissante.
- 4 GREC, et ce qu'on ne fait pas.** Glace 15 à 20 minutes en surveillant la CSM, repos, élévation, compression légère non restrictive. Chaleur et massage plus tard, jamais sur une contusion. Acétaminophène ou AINS pour la douleur et l'enflure.
- 5 Les luxations : reconnaître, immobiliser, ne pas jouer au chirurgien.** Épaule : bras écarté du corps, masse à l'avant ; immobiliser sans réduire, évacuer vite. Doigt, orteil, rotule sans fracture suspectée : réduction douce possible, puis CSM. Hanche et genou : soins avancés seulement.

03

Les attelles

Les principes d'immobilisation que vous appliquerez en classe

Immobiliser, c'est empêcher le mouvement inutile pour soulager la douleur, relâcher les muscles, protéger vaisseaux et nerfs, et éviter qu'une fracture fermée devienne ouverte pendant le transport. Après toute immobilisation : CSM.



Figure 3 — Quatre temps, dans cet ordre, quelle que soit l'attelle.

- 1 Quoi immobiliser : la règle des voisins.** Os fracturé : l'articulation au-dessus et celle en dessous. Articulation blessée : l'os au-dessus et celui en dessous. Pour les membres inférieurs, la jambe saine peut servir d'appui ; le genou reste fléchi de 5 à 10 degrés avec un remplissage sous le creux.
- 2 Trois familles d'attelles, une improvisation.** Souples (sac de couchage, vêtements, mousse), rigides (bois, plastique, aluminium coussiné type SAM Splint), anatomiques (doigt contre doigt, jambe contre jambe). Improvisées : bâton, pagaie, armature de sac, matelas de sol. L'attelle de traction est réservée au fémur, contre-indiquée aux articulations.
- 3 Les configurations à connaître.** Simple, double, pince à sucre (immobilisation des deux axes), écharpe simple et tubulaire, bandage en huit pour la clavicule. En classe, la liste se limite à : clavicule, humérus, coude, avant-bras, poignet, genou, cheville, pied, jambe.
- 4 Ferme, jamais restrictive.** Le ruban adhésif garde sa compression, les bandages élastiques se relâchent ou se resserrent : ne les serrez pas trop. Laissez une extrémité accessible pour la CSM. En immobilisation prolongée, relâchez périodiquement.
- 5 Par temps froid, l'attelle refroidit le membre.** Une victime immobilisée produit moins de chaleur et la circulation ralentit dans le membre : risque d'hypothermie et de gelure. Isolez le membre, isolez la victime, surveillez la couleur et la chaleur des extrémités.